

Periimplantitis-Therapie und Implantaterhalt

Eine Entzündung am Implantat lässt sich häufig behandeln. Ziel ist, die Entzündung zu kontrollieren, weiteren Verlust des tragenden Knochens zu verhindern und ein sinnvoll nutzbares Implantat möglichst langfristig zu erhalten.

Früh erkennen verbessert die Möglichkeiten. Eine Periimplantitis kann lange wenig oder keine Schmerzen verursachen. Blutung, Eiter, Schwellung, unangenehmer Geschmack oder eine Veränderung am Zahnersatz sollten deshalb untersucht werden.

Schleimhautentzündung oder Periimplantitis

Periimplantäre Mukositis: Die Schleimhaut um das Implantat ist entzündet, ohne zusätzlichen entzündungsbedingten Verlust des tragenden Knochens. Mit professioneller Behandlung und wirksamer täglicher Pflege kann die Entzündung häufig zurückgehen.

Periimplantitis: Zusätzlich zur Entzündung ist der Knochen betroffen, der das Implantat hält. Die Behandlung ist aufwendiger; eine normale Zahnreinigung allein reicht dann häufig nicht aus. Bereits verlorener Knochen wächst nicht automatisch vollständig nach.

Warum eine Entzündung entsteht

Bakterielle Beläge an schwer zugänglichen Implantatoberflächen spielen eine zentrale Rolle. Eine frühere oder bestehende Parodontitis, unzureichende Reinigung und fehlende regelmäßige Betreuung erhöhen das Risiko. Rauchen, eine ungünstige Blutzuckereinstellung und andere individuelle Faktoren werden mitbeurteilt.

Auch Zementreste, ungünstige Kronenformen, schlecht zugängliche Zwischenräume oder eine ungünstige Implantatposition können die Reinigung erschweren. Es geht nicht um Schuldzuweisungen: Gemeinsam suchen wir nach veränderbaren Ursachen.

Was wir untersuchen

Wir prüfen Schleimhaut, Blutung oder Eiter bei vorsichtiger Sondierung, Taschentiefen, Knochenverhältnisse und Pflegbarkeit. Röntgenaufnahmen werden möglichst mit früheren Bildern verglichen. Ein DVT ist nur bei einer zusätzlichen konkreten Fragestellung erforderlich, nicht automatisch bei jeder Periimplantitis.

Wir unterscheiden eine lockere Krone oder Verbindungsschraube von einem im Knochen beweglichen Implantatkörper. Eine Schraubenlockerung allein ist keine Periimplantitis. Bitte nichts selbst festdrehen und eine bewegliche Versorgung nicht weiter belasten.

Erste Behandlungsstufe ohne Operation

Wenn Implantat und Zahnersatz grundsätzlich erhaltungswürdig sind, beginnt die Behandlung in der Regel mit einer nichtchirurgischen Phase. Sie schafft die Voraussetzungen für eine stabile Heilung und gegebenenfalls für einen späteren Eingriff.

- **Professionelle Reinigung:** Beläge und erreichbare Ablagerungen werden oberhalb und unterhalb des Schleimhautrandes mit geeigneten Instrumenten entfernt. Eine örtliche Betäubung kann dies erleichtern.
- **Tägliche Pflege:** Wir zeigen Ihnen passende Bürsten und Hilfsmittel für die tatsächlichen Zwischenräume. Die Reinigung muss wirksam und im Alltag durchführbar sein.
- **Zahnersatz prüfen:** Zementreste und andere Hindernisse werden soweit möglich beseitigt. Manchmal muss eine Krone oder Brücke abgenommen, angepasst oder erneuert werden. Das stimmen wir mit Ihrer Hauszahnarztpraxis ab.
- **Begleitende Faktoren behandeln:** Eine aktive Parodontitis wird mitbehandelt. Rauchstopp und eine gute Einstellung eines Diabetes unterstützen die Therapie. Medikamente und relevante Erkrankungen gehören in die Planung.

Erneute Bewertung nach der Vorbehandlung

Nach einer Heilungsphase beurteilen wir die Situation erneut, häufig nach etwa sechs bis zwölf Wochen. Entscheidend sind weniger Entzündung, keine Eiterung, günstigere Taschentiefen und eine zuverlässig mögliche Reinigung. Bei akuten Beschwerden erfolgen frühere Kontrollen.

Ist die Situation ausreichend stabil, beginnt die unterstützende Betreuung. Bleiben tiefe entzündete Taschen bestehen, kann ein chirurgischer Zugang erforderlich sein. Fortgeschrittene Befunde sollten nicht durch immer wiederholte, unzureichende Reinigungen unnötig lange unbehandelt bleiben.

Welche Rolle spielen Antibiotika und Spüllösungen

Antibiotika sind keine routinemäßige Ergänzung jeder Periimplantitis-Behandlung und ersetzen die Reinigung der Oberfläche nicht. Sie kommen bei einer gesonderten medizinischen Indikation infrage, beispielsweise einer sich ausbreitenden akuten Infektion. Falls wir sie verordnen, erläutern wir Grund, Einnahme und Risiken.

Eine antiseptische Mundspüllösung kann zeitweise unterstützen, etwa wenn eine Operationswunde zunächst nicht mechanisch gereinigt werden darf. Sie ersetzt dauerhaft weder die tägliche Reinigung noch professionelle Betreuung. Zusätzliche Geräte oder Verfahren sind keine Garantie für einen besseren Implantaterhalt.

Vor einer geplanten Operation muss die Reinigung funktionieren. Wenn die Pflege noch nicht ausreichend möglich ist, verbessern wir zunächst Anleitung, Hilfsmittel oder die Zugänglichkeit der Versorgung.

Chirurgische Behandlung

Unter wirksamer örtlicher Betäubung wird die Schleimhaut so eröffnet, dass die betroffene Implantatoberfläche direkt zugänglich ist. Entzündlich verändertes Gewebe und Ablagerungen werden entfernt, die Oberfläche wird gereinigt. Welches weitere Vorgehen sinnvoll ist, hängt vor allem von Defektform, Implantatposition, Weichgewebe und Zahnersatz ab.

Drei mögliche Vorgehensweisen

Zugang und Reinigung: Der direkte Zugang ermöglicht eine gründlichere Bearbeitung als durch eine tiefe Tasche. Anschließend wird das Gewebe wieder vernäht.

Verbesserung der Pflegbarkeit: Bei geeigneten Befunden werden Weichgewebe und gegebenenfalls störende Kanten angepasst, um schlecht reinigbare Taschen zu reduzieren. Dabei kann der Implantathals stärker sichtbar werden. Die ästhetischen Folgen besprechen wir besonders im sichtbaren Bereich.

Rekonstruktive Behandlung: Bei geeigneten, von Knochen begrenzten Defekten kann ein Aufbau mit Knochen beziehungsweise Knochenersatzmaterial und gegebenenfalls einer Membran erwogen werden. Material und Herkunft werden vorher besprochen. Ein vollständiger Knochengewinn oder eine erneute feste Knochenanlagerung an der gesamten Implantatoberfläche sind nicht garantiert. Die Verfahren können kombiniert werden.

Grenzen des Implantaterhalts

Ein Erhaltungsversuch ist vor allem dann sinnvoll, wenn das Implantat fest verankert, funktionell brauchbar und künftig gut pflegbar ist. Bei einem beweglichen Implantatkörper, einer Fraktur, sehr ungünstiger Position oder weit fortgeschrittener beziehungsweise trotz Therapie fortschreitender Zerstörung kann die Entfernung die bessere Entscheidung sein.

Es gibt keinen einzelnen Grenzwert, der jeden Fall entscheidet. Wir wägen Erfolgsaussicht, Aufwand, verbleibenden Knochen und Ihre Wünsche ab. Eine erneute Implantation ist nicht automatisch möglich; Alternativen wie eine Brücke oder herausnehmbarer Zahnersatz werden gegebenenfalls separat geplant.

Risiken und mögliche Folgen

Möglich sind Schmerzen, Schwellung, Blutergüsse, Nachblutung, Infektion, Wundöffnung, Narben und Schleimhautrückgang mit sichtbaren Implantatanteilen. Je nach Region können Nachbarzähne, Nerven oder die Kieferhöhle betroffen sein; Gefühlsstörungen können selten anhalten. Bei einem Aufbau sind Freilegung oder Verlust von Material beziehungsweise Membran und eine weitere Operation möglich.

Zahnersatz kann bei Abnahme beschädigt werden oder anschließend nicht mehr passen. Trotz sorgfältiger Behandlung kann die Entzündung bestehen bleiben oder wiederkehren; auch eine spätere Implantatentfernung ist möglich. Besondere Risiken einer geplanten Oberflächenbearbeitung oder Knochenentnahme werden gesondert erläutert.

Betäubung und Vorbereitung

Standard ist die Lokalanästhesie. Sedierung oder Narkose sind zusätzliche Möglichkeiten bei individuellem Bedarf. Bitte nennen Sie alle Erkrankungen, Medikamente, Allergien, eine antiresorptive Therapie und frühere Probleme mit Betäubungen. Blutverdünner nicht eigenständig absetzen.

Methode	Beschreibung	Kosten
Lokalanästhesie Standard	Wach, kein Schmerz – nur Druck. Bei Schmerzwahrnehmung wird sofort nachbetäubt. ÖPNV nach Hause erlaubt.	Abrechnung im individuellen Kostenplan; keine pauschale GKV-Zusage.
Orale Sedierung (Tavor) Komfort	Tablette ca. 60 Min. vorher. Kein Schlaf, deutliche Stressreduktion. Vitalparameter werden überwacht. Begleitperson notwendig, 24 Std. nicht verkehrsfähig. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 80 € Eigenleistung
Dämmerschlaf (i.v.) Komfort	Professionelles Narkoseteam, medikamentös an der Schlaf-Wachgrenze, kooperativ, meist keine Erinnerung. Postop. Aufwachraum mit Vitalüberwachung. Nur dienstags. Nüchtern ab 22 Uhr nichts essen, ab 6 Uhr nichts trinken. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 230 € Eigenleistung
Vollnarkose Komfort	Echter Tiefschlaf, Beatmung über die Nase in die Lunge, keine Wahrnehmung des Eingriffs. Postop. Aufwachraum mit Vitalüberwachung. Nur dienstags. Nüchtern wie Dämmerschlaf. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 450 € Eigenleistung

Standard ist die Lokalanästhesie – für die allermeisten Patienten vollkommen ausreichend. Sedierung ist eine optionale Komfortzubuchung als Eigenleistung. Die Wirkung wird vor Beginn geprüft; bei Schmerzen wird sofort nachbetäubt. Nach Sedierung oder Narkose sind Abholung aus der Praxis und 24 Stunden Verzicht auf aktive Teilnahme am Straßenverkehr erforderlich. Persönliche Nüchternanweisungen haben Vorrang.

Risiken der Betäubung

Örtliche Betäubungsmittel können Blutergüsse, vorübergehende oder selten anhaltende Gefühlsstörungen, allergische Reaktionen sowie bei unbeabsichtigter Gefäßinjektion Kreislauf- oder Herzrhythmusstörungen verursachen. Sedierung und Narkose können Atmung und Kreislauf beeinträchtigen; möglich sind Übelkeit, Erbrechen, Aspiration und Verletzungen bei der Atemwegssicherung. Schwere Komplikationen sind selten. Bei geplanter Sedierung oder Narkose erfolgt eine gesonderte individuelle Aufklärung.

Kosten und Planung

Die Kosten hängen von Anzahl und Lage der Implantate, Vorbehandlung, Operationsumfang, möglichen Aufbaumaterialien und notwendigen Änderungen am Zahnersatz ab. Sie erhalten vorab eine individuelle Kostenaufstellung. Eine vollständige Kostenübernahme durch die Versicherung ist nicht vorauszusetzen; mögliche Eigenleistungen werden vor der Behandlung vereinbart.

Die auf unserer Recall-Seite genannten Kosten bis zu 110 € betreffen die Kontrolle. Sie sind kein Preis für die Periimplantitis-Therapie. Kosten für Zahnersatz, weitere Eingriffe und langfristige Betreuung werden gesondert erläutert.

Nach einer chirurgischen Behandlung

- **Die operierte Stelle entlasten:** Nicht auf den frisch operierten Kieferkamm beißen. Keine feste Nahrung direkt auf der Wunde kauen; zunächst weiche Kost und möglichst die andere Seite nutzen. Provisorien und Prothesen dürfen nicht auf die Wunde drücken.
- **Bis die Betäubung abgeklungen ist:** Nicht kauen und nichts Heißes trinken, um Biss- und Hitzeverletzungen zu vermeiden.
- **Sauber halten und Wunde schützen:** Die übrigen Zähne normal vorsichtig reinigen. An der Operationsstelle beginnen Sie mit Bürste und Zwischenraumpflege erst nach unserer Freigabe. Verordnete antiseptische Spüllösung nur in der vereinbarten Konzentration und Dauer verwenden; am Operationstag nicht kräftig spülen.
- **Schonung:** Behutsam mit eingewickelter Kühltasche kühlen, kein Eis direkt auf die Haut. Sport, starke Hitze und Alkohol zunächst meiden. Rauchen und Dampfen während der Heilung vermeiden; die weitere Rauchentwöhnung unterstützt den Langzeiterfolg.
- **Kontrollen:** Wundkontrolle wahrnehmen; Fäden werden gewöhnlich nach ein bis zwei Wochen entfernt. Dauer der Entlastung und Wiederbeginn der Reinigung richten sich nach dem Eingriff, bei Knochenaufbau besonders sorgfältig.

Schmerzen behandeln

Schmerzmittel nur nach individueller Empfehlung. Die Übersicht gilt für geeignete Erwachsene. Bei Kindern, Schwangerschaft, geringem Körpergewicht sowie Leber-, Nieren- oder Magenenerkrankungen müssen Mittel und Dosierung angepasst werden.

Mittel	Einnahme nach Freigabe	Hinweis
Ibuprofen 600 mg	Alle 6–8 Stunden, höchstens 3-mal täglich	Nicht nüchtern; Gegenanzeigen beachten
Paracetamol 500–1000 mg	Alternativ/ergänzend alle 6 Stunden; höchstens 4 g/Tag	Nur bei geeignetem Gewicht und gesunder Leber; keine Doppelmedikation
Novalgin-Tropfen	Bei stärkeren Schmerzen bis zu 4 × 30 Tropfen täglich, nur nach Verordnung	Dosierung für 500 mg/ml; Verordnung hat Vorrang

Kein Aspirin/ASS als zusätzliches Schmerzmittel verwenden, da es Nachblutungen begünstigt. Ärztlich verordnetes ASS nicht selbst absetzen. Bei Fieber, Schüttelfrost, Halsschmerzen oder neuen schmerzhaften Schleimhautstellen unter Novalgin das Mittel absetzen und sofort ärztlich abklären lassen.

Warnzeichen

Bei zunehmenden Schmerzen oder Schwellung, Eiter, Fieber, Wundöffnung, anhaltender Blutung oder neuer Beweglichkeit sofort Kontakt aufnehmen. Bei leichter Nachblutung eine saubere Kompresse etwa 20 Minuten gleichmäßig aufdrücken, sofern die Stelle zugänglich ist.

Bei zunehmenden Beschwerden: Praxis 06151 786540; außerhalb der Praxisprechzeiten nach dem Eingriff +49 151 10437450. Falls nicht erreichbar: zahnärztlicher Notdienst 01805 60 70 11. Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge: 112.

Langfristige Betreuung gehört zur Therapie

Nach behandelter Periimplantitis besteht weiterhin ein erhöhtes Risiko für erneute Entzündungen. Deshalb planen wir zunächst engmaschige Kontrollen und professionelle Reinigung, häufig im Abstand von etwa drei Monaten. Spätere Abstände werden nach Befund, Risiko und Pflege festgelegt.

Ein jährlicher Kontrolltermin allein genügt nach Periimplantitis in der Regel nicht. Die engmaschige Betreuung wird zwischen unserer Praxis und Ihrer Hauszahnarztpraxis abgestimmt. Die auf der allgemeinen Recall-Seite beschriebenen jährlichen chirurgischen Kontrollen betreffen die reguläre Betreuung bei stabilen Verhältnissen.

Woran wir den Erfolg beurteilen

Wir prüfen Entzündungszeichen, Eiterung, Taschentiefen, Reinigung und Stabilität der Versorgung. Der Knochenverlauf wird mit geeigneten Röntgenaufnahmen bei entsprechender Indikation verfolgt. Ein Implantat kann auch mit reduziertem Knochenangebot stabil bleiben. Entscheidend ist, dass die Erkrankung zur Ruhe kommt und die Versorgung nutzbar bleibt.

Zeitlicher Verlauf

Zu Beginn: Untersuchung, Unterlagenvergleich, Reinigung und Verbesserung der Pflege. **Nach ungefähr sechs bis zwölf Wochen:** erneute Bewertung nach der nichtchirurgischen Therapie. **Falls operiert wird:** frühe Wundkontrollen und schrittweise Freigabe. **Über die folgenden Monate:** Beurteilung der Gewebeheilung und des Knochenverlaufs. **Dauerhaft:** individuelle unterstützende Betreuung. Die Termine richten sich nach Ihrem Befund.

Häufige Fragen

Kann mein Implantat sicher gerettet werden? Das lässt sich nicht versprechen. Wir erläutern die individuelle Prognose und prüfen während der Behandlung, ob der Erhalt weiterhin sinnvoll ist.

Reicht ein Knochenaufbau? Nein. Eine Rekonstruktion kann bei passenden Defekten ergänzen, setzt aber die Kontrolle der Entzündung und eine dauerhaft gute Pflegbarkeit voraus.

Kann ich abwarten, solange nichts wehtut? Eine bestätigte Periimplantitis sollte behandelt werden. Ohne Therapie kann weiterer tragender Knochen verloren gehen und eine spätere Versorgung aufwendiger werden.

Checkliste für das Gespräch

- Sind Diagnose, Prognose und mögliche Alternativen erklärt?
- Ist die Versorgung zu Hause zuverlässig zu reinigen?
- Sind mögliche Änderungen am Zahnersatz und die Kosten abgestimmt?
- Sind Kontrolle, Wundpflege und langfristige Betreuung vereinbart?



QR-Code mit dem Smartphone scannen
<https://patienteninfo.mkg-im-carree.de/periimplantitis/>